

1 AS 4 PERGUNTAS DO CONTROLE

janela: últimas 4 semanas

1. Teve sintomas de dia mais de 2x por semana?
2. Acordou à noite por causa da asma?
3. Usou a bombinha de alívio mais de 2x por semana?
4. A asma limitou alguma atividade?

NENHUM “sim”	CONTROLADA — mantenha. Se está boa há 2-3 meses, considere reduzir a dose .
1 ou 2 “sim”	PARCIALMENTE CONTROLADA — revise técnica e adesão antes de mexer na dose.
3 ou 4 “sim”	NÃO CONTROLADA — revise técnica e adesão; se estiverem boas, suba de etapa .

⚠ Em criança de até 5 anos os cortes são mais duros: sintoma de dia > 1x/semana e alívio > 1x/semana já contam.

⚠ **CONTROLE ≠ GRAVIDADE.** Controle = quanto o tratamento suprime os sintomas. Gravidade = quanto de remédio é preciso para controlar.

↳ E os fatores de risco se avaliam à parte — “mesmo com sintomas controlados”. Quem teve 1 crise no ano passado segue sendo de risco, ainda que hoje esteja bem.

2 PROCURE O RISCO

separado do controle

- Os 8 fatores de risco de exacerbação:
- ≥ 1 crise no último ano
 - Tratamento só com bombinha de alívio (sem corticoide inalatório)
 - Uso excessivo de alívio
 - Baixa adesão ou técnica errada
 - VEF₁ reduzido · tabagismo · eosinofilia
 - Vulnerabilidade social
- ↳ Por que “só alívio” é risco de **MORTE**: alivia o sintoma sem tocar na inflamação. O paciente se sente bem, para de procurar ajuda, e chega à emergência já em falência.

3 SUBIR OU DESCER?

- ANTES de subir, cheque sempre:** técnica inalatória · adesão · diagnóstico alternativo · comorbidades (rinite, refluxo, apneia, obesidade).
- ↳ **Subir dose não conserta bombinha mal usada.**
- SUBIR** — segue descontrolada ou exacerbando **mesmo com adesão e técnica boas**.
- DESCER** — boa resposta por 2 a 3 meses → considerar reduzir.
- Após uma crise:** volta ao nível anterior em 2-4 semanas — **exceto** se a crise veio de controle cronicamente ruim: aí **intensifica**.

4 AS DOSES POR ETAPA

o que temos na farmácia

≥ 12 anos	Baixa	Média	Alta	6 a 11 anos	Baixa	Média	Alta
Beclometasona	200-500	>500-1.000	>1.000	Beclometasona	100-200	>200-400	>400
Budesonida	200-400	>400-800	>800	Budesonida	100-200	>200-400	>400

mcg/dia · dose diária total. Subir de faixa ≈ dobrar o teto anterior. Dose alta é para uma minoria e por tempo limitado.

- OS DOIS REGIMES DO PROTOCOLO**
- Regime 1 (preferencial):** corticoide inalatório + formoterol na mesma bombinha — alívio e manutenção juntos (AIR/MART). Teto 12 inalações/dia. a combinação não consta na lista da farmácia
- Regime 2 (alternativa prevista):** beclometasona diária + bombinha de alívio sob demanda. **É a rota B do próprio protocolo quando o Regime 1 não é viável.**
- ↳ Nunca tratar asma só com bombinha de alívio — risco aumentado de crise grave e morte.

- EM TODA CONSULTA — os 6 itens que não dependem de estoque**
1. Técnica: peça para **DEMONSTRAR** — não pergunte “sabe usar?”. **Com espaçador.**

2. Adesão sem julgamento: “muita gente esquece — quantos dias usou na semana

3. Plano de ação escrito — revisado a cada visita.

4. Vacinas: influenza e covid-19 em dia.

5. Comorbidades que sabotam: rinite · refluxo · apneia do sono · obesidade.

6. Gatilhos e ambiente: fumaça (inclusive vape) · ácaro · mofo · pelo · exposição no trabalho.
- 17 **Reavaliar a cada 3-6 meses** após início ou ajuste · e **sempre após uma crise** (2-7 dias; criança 1-2 dias). **Função pulmonar** no diagnóstico, em 3-6 meses e depois a cada 1-2 anos.

1 AS 3 PERGUNTAS QUE CLASSIFICAM

janela: últimos 12 meses

1. Quantas crises você teve no último ano?
2. Alguma delas te internou?

3. Quanto a falta de ar te limita? — aplique mMRC ou CAT
- O protocolo deixa você escolher a escala com que tiver mais familiaridade.

Crise MODERADA = precisou de antibiótico ou corticoide, tratada fora do hospital. Crise GRAVE = internou.

Grupo	Sintomas	Crises em 12 meses
A	mMRC 0-1 e/ou CAT < 10	nenhuma, ou 1 moderada sem internação
B	mMRC ≥ 2 e/ou CAT ≥ 10	nenhuma, ou 1 moderada sem internação
E	qualquer nível	≥ 1 internação OU ≥ 2 moderadas

⚠ A janela é diferente da asma. Asma se controla olhando as últimas 4 semanas. DPOC se classifica olhando os últimos 12 meses.
↳ Uma crise agora muda o grupo na hora: a 2ª moderada do ano — ou a 1ª internação — leva direto ao grupo E.

2 mMRC

corte: 0-1 × ≥2

Grau 0	Falta de ar só em esforço intenso (correr, nadar, esporte)
Grau 1	Falta de ar ao andar apressado no plano ou em subida
Grau 2	Anda mais devagar que gente da mesma idade · ou precisa parar para respirar no plano
Grau 3	Precisa parar depois de menos de 100 m ou alguns minutos no plano
Grau 4	Não sai de casa · falta de ar ao se vestir

3 CAT

corte: <10 × ≥10

- 8 perguntas, cada uma de 0 a 5 (0 = nada · 5 = muito):
- tosse · catarro no peito · aperto no peito
 - falta de ar ao subir ladeira ou um lance de escada
 - limitação nas atividades em casa
 - confiança para sair de casa
 - sono · energia
- ↳ Some tudo: 0 a 40. O corte que separa A de B é 10. A escala completa está no Material Suplementar do PCDT (p.39).

4 TRATAMENTO POR GRUPO · E QUANDO MEXER

GRUPO A	Broncodilatador conforme necessidade — curta ou longa ação. Se disponível, prefira longa ação.
GRUPO B	LAMA + LABA contínuo (umeclidínio + vilanterol). Broncodilatador de curta ação para alívio.
GRUPO E	LAMA + LABA de partida. Terapia tripla (com corticoide inalatório) conforme perfil e eosinófilos.

EM TODA MUDANÇA DE TRATAMENTO, NESTA ORDEM: 1º reveja sintomas e risco de crise (histórico e eosinófilos) · 2º cheque técnica inalatória, adesão e as medidas não medicamentosas · 3º só então ajuste a medicação.

ACRESCENTAR corticoide inalatório: crises frequentes E eosinófilos ≥ 300 células/μL.

RETIRAR corticoide inalatório: sem benefício · eosinófilos < 100 · sem histórico de crises frequentes · ou evento adverso (pneumonia, candidíase oral).

⚠ Corticoide inalatório sozinho NÃO se usa na DPOC — só em terapia tripla. Na asma o gatilho para subir é o sintoma; na DPOC é crise + eosinófilo.

✓ EM TODA CONSULTA — o que mais muda o prognóstico não custa nada

1. CESSAÇÃO DO TABAGISMO — “a intervenção mais eficaz”. A única que muda a progressão da doença.

2. Técnica inalatória — “monitorada em todas as consultas”. Com espaçador (reduz candidíase e rouquidão).

3. Adesão — técnica errada é a causa mais comum de “não melhorou”.

4. Vacinas: influenza anual para todos · pneumocócica 13 + 23 em sintomáticos e exacerbadores (6 meses de intervalo, começando pela 13).

5. Reabilitação pulmonar · atividade física regular · avaliação nutricional (IMC baixo é fator de risco).

6. Plano de ação escrito — autocuidado e quando procurar ajuda.

17 Após uma crise: reavaliar em 1 a 4 semanas · reavaliação funcional completa em 12 a 16 semanas. GOLD 3 e 4 devem ser acompanhados também por pneumologista.